

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

JOAO EVANGELISTA DA SILVA FRANCA

IDADE: 53 PESO: 103 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: Mecânico

SINTOMAS: Sonolência diurna, Ronco, cansaço

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Benetka 30

MÉDICO: Dra Aline Dias (Otorrino)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: N JANTAR: 20h-21h

HORA QUE DORME: 2h HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILHO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM ☒ X NA SEMANA () NÃO 2x/semana

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Bucal BANHEIRO: 2-3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 90cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 72 elh SPO2: 66% min

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: ~~neoplasia~~ HAS / nódulos estrutural

CIRURGIAS: ☒ NASAL ☒ AMIGDALECTOMIA mediastino

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:

COMORBIDADE: ☒ RESPIRATÓRIA ☒ ENDÓCRINA ☒ CARDÍACA

☒ ORTOPÉDICA ☒ NEUROLÓGICA ☒ OUTROS

07/08/24 Artelição

Mar. cream wear
Pillow (5h)

14/08/24 P= 10 cmH₂O P95% = 11,8 cmH₂O.

IAH = 2,7 elh

min uso = 8h42'

fuga = 34 l/min

Fixo: 11 cmH₂O

Silvia

20/08/24 P= 11 cmH₂O

IAH = 3,2 elh

min de uso: 8h7'

fuga: 35,4 l/min

Oriento ajuste de máscara
troca programada p/ 1

Natasha

18/09/24 P= 11 cmH₂O

IAH = 1,6 elh

min uso = 8 horas

fuga = 3 l/min

Arti mundo Bem - Adaptado.

10/06/25 P= 11 cmH₂O

IAH = 0,9 elh

min de uso: 7h53'

fuga: 27,9 l/min

Comprei máscara Universal nasal

Oriento higiene e troca
de filtro

Natasha

Nome: JOÃO EVANGELISTA DA SILVA FRANCA

Data de Nascimento: 10-5-1971

IMC: 34,89

Sexo: Masculino

Data do exame: 16-07-2024

Peso: 95 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DRA. ALINE DIAS ELIAS

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 494,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 3,0 e 138,5 minutos. O tempo total de sono foi de 395,0 min, eficiência de 79,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 74,3%; estágio N3: 6,7%; sono REM: 16,1%. O índice de despertares foi de 46,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 72,0/hora, sendo 27 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 298 hipopnéias. A SpO2 média foi de 86% e a mínima de 66%, permanecendo 75,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 31 - 225 bpm e NREM de 35 - 98 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (20), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 72,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=66%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

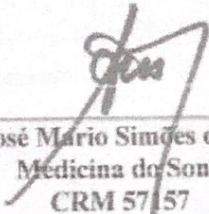
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157